

Aftöz Ülser ve Ekstraintestinal Bulgular

Rekürren aftöz stomatitli çocukta artrit, eritema nodozum, üveit ve piyoderma gangrenozum gibi ekstraintestinal bulguların değerlendirilmesi; IBD ve çölyak taramasının basamaklandırılması ile dozlu tedavi.

Aftöz ülser

Ekstraintestinal bulgu

IBD taraması

Çölyak

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Aftöz ülser (aft), oral mukozada tekrarlayan, ağrılı, keskin sınırlı, fibrinöz zeminli ülserdir. Rekürren aftöz stomatit (RAS) çoğunlukla idyopatiktir; ancak ekstraintestinal bulgularla (artrit, eritema nodozum, üveit, piyoderma gangrenozum) birlikte olduğunda inflamatuvar barsak hastalığı (IBD), çölyak, Behçet, PFAPA ve besinsel eksiklikler açısından sistemik değerlendirme zorunludur.

Öykü — anahtar sorular

- Aft sıklığı, sayısı, boyutu (minör <10 mm, majör >10 mm, herpetiform), iyileşme süresi ve skar bırakıp bırakmadığı
- Genital ülser, oküler bulgu (kızarıklık/ağrı/bulanık görme), paterji öyküsü → Behçet
- Kronik/kanlı ishal, karın ağrısı, tenezm, perianal fistül/fissür, gece semptomu, kilo kaybı/büyüme duraklaması → IBD
- Kronik ishal, karın şişliği, glutene bağlı semptom, boy kısalığı, dirençli demir eksikliği → çölyak
- Periyodik ateş + farenjit + servikal adenit (PFAPA), aile öyküsü, ilaç kullanımı
- Eklem ağrısı/şişliği, deri lezyonları, fotofobi

Muayene — sistematik

- Antropometri: boy/kilo persantili ve büyüme hız eğrisi (IBD ve çölyakta duraklama)
- Oral: ülser lokalizasyonu, sayısı; anguler keilit, glossit (B12/demir eksikliği)
- Abdominal: hassasiyet, kitle, hepatosplenomegali; perianal inspeksiyon (fistül, skin tag, fissür)
- Deri: pretibial eritema nodozum, piyoderma gangrenozum, psöriaziform lezyon
- Eklem: artrit/entezit (sakroiliak, diz, ayak bileği), şişlik ve hareket kısıtlılığı
- Göz: konjonktival hiperemi, hipopiyon; şüphede yarık lamba ile üveit değerlendirmesi

Tek başına, seyrek, skarsız minör aft + normal büyüme + alarm bulgusu yokluğu genellikle idyopatik RAS lehinedir; ekstraintestinal bulgu varlığı sistemik hastalık taramasını tetikler.

Aftöz ülser + ekstraintestinal bulgu birlikteliğinin altında yatan başlıca kategoriler.

Mekanizma, hedefe yönelik tetkik ve tedaviyi belirler.

İnflamatuvar barsak hastalığı (IBD)

- Crohn'da oral aft, majör/lineer ülser sık; kolonik tutulumda ekstraintestinal bulgu belirgin
- Periferik/aksiyel artrit, eritema nodozum, piyoderma, üveit eşlik eder
- Th1/Th17 aracılı transmural (Crohn) veya mukozal (ÜK) inflamasyon

Çölyak hastalığı

- Rekürren aft, glossit, anguler keilit; demir/folat eksikliğiyle ilişkili
- Gluten aracılı otoimmün enteropati; anti-tTG IgA + total IgA
- Dermatitis herpetiformis, artralji eşlik edebilir

Behçet hastalığı

- Rekürren oral aft (zorunlu) + genital ülser + üveit + paterji
- Gastrointestinal Behçet ileoçekal derin ülserlerle IBD'yi taklit eder
- Nötrofilik/vaskülitik; HLA-B51 ilişkisi

Besinsel eksiklikler

- Demir, B12, folat, çinko eksikliği rekürren aftı tetikler/ağırlaştırır
- Malabsorpsiyon (çölyak, Crohn) ikincil eksikliğe yol açar
- Replasman ile aft sıklığı belirgin azalır

Otoinflamatuvar (PFAPA vb.)

- PFAPA: periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit, servikal adenit
- Düzenli aralıklı ataklar, ataklar arası tam sağlık ve normal büyüme
- MEFV ilişkili FMF ayırıcı tanıda

İdyopatik / diğer

- Basit rekürren aftöz stomatit (en sık); stres, travma, hormonal tetikleyici
- İlaç ilişkili (NSAİİ, nikorandil), immün yetmezlik (siklik nötropeni)
- Ekstraintestinal bulgu yoksa ve büyüme normale gözlem uygun

03 Karar akışı

Rekürren aftöz ülserli çocukta ekstraintestinal bulgu ve alarm işaretlerine göre tanısal yol.

BAŞLANGIÇ

Rekürren aftöz ülser (≥3 atak/yıl)

Öykü, tam sistemik muayene, büyüme değerlendirmesi.

ADIM 1

Ekstraintestinal bulgu tara

Artrit, eritema nodozum, üveit, piyoderma; perianal ve genital bakı; büyüme eğrisi.

KARAR 1

Alarm bulgusu veya ekstraintestinal tutulum var mı?

Kanlı ishal, kilo kaybı/büyüme duraklaması, perianal hastalık, artrit, eritema nodozum, üveit, piyoderma.

EVET → Sistemik hastalık taraması

HAYIR → Basit RAS yönetimi

İLERİ TETKİK

IBD + çölyak + inflamasyon paneli

TKS, ferritin, CRP/ESH, albümin, fekal kalprotektin, anti-tTG IgA + total IgA. Fekal kalprotektin veya seroloji pozitifse ileokolonoskopi + üst endoskopi + biyopsi. Üveit varsa yarık lamba muayenesi.

GÖZLEM + EKSİKLİK TARAMASI

Besinsel eksiklikleri dışla

TKS, ferritin, B12, folat, çinko; eksik varsa replase et. Topikal semptomatik tedavi. Atak sıklaşır, ekstraintestinal bulgu çıkar veya büyüme etkilenirse Karar 1'e dön.

KARAR 2

Genital ülser + üveit + paterji birlikteliği var mı?

Rekürren oral aft + bu bulgular Behçet ölçütlerini düşündürür.

EVET → Behçet değerlendirmesi

HAYIR → IBD/çölyak yönetimini sürdür

MULTİDİSİPLİNER

PEDBD ölçütleri + oftalmoloji

TANIYA YÖNEL

Endoskopi/seroloji sonucuna göre tedavi

IBD veya çölyak doğrulanırsa hastalığa özgü tedavi başlat; PFAPA düşünülüyorsa

HLA-B51, paterji testi, oftalmolojik üveit değerlendirilmesi; GİS Behçet şüphesinde endoskopi (ileoçekal derin ülser).

periyodisiteyi belgele.

04 Basamaklı tetkik

Düşük invaziften kesin tanıya doğru basamaklandırma. Fekal kalprotektin ve serolojiler endoskopi kararını yönlendirir.

Aftöz ülser + ekstraintestinal bulgu — basamaklı tetkik planı

BASAMAK	TETKİK	EŞİK / NOT
Basamak 1 — Temel kan	TKS, ESH, CRP, albümin, ferritin, demir, B12, folat, çinko	Anemi, trombositoz, düşük albümin, yüksek CRP/ESH IBD lehine; eksiklik replase edilir
Basamak 2 — Çölyak serolojisi	Anti-tTG IgA + total IgA (IgA eksikse anti-tTG/DGP IgG)	ESPGHAN 2020: anti-tTG IgA >10× ÜSN + EMA pozitifse biyopsisiz tanı seçeneği
Basamak 3 — Fekal belirteç	Fekal kalprotektin (± laktoferrin), gaita kültürü/parazit	Kalprotektin >250 µg/g anlamlı; enfeksiyöz nedeni dışla
Basamak 4 — Endoskopi	İleokolonoskopi + üst GİS endoskopisi, çoklu biyopsi	Kalprotektin/seroloji pozitif veya alarm bulgusu varsa; Porto ölçütlerine uygun IBD tanısı
Basamak 5 — Görüntüleme	MR enterografi (ince barsak), gerekirse batın MR/US	Crohn'da ince barsak ve penetran/striktüran hastalık haritalaması
Basamak 6 — Hedefe yönelik	HLA-B51, paterji, yarık lamba (üveit); MEFV; ANA	Behçet/otoinflamatuvar/oküler tutulum şüphesinde

Anti-tTG IgA + total IgA

Fekal kalprotektin

İleokolonoskopi + üst endoskopi

MR enterografi

Yarık lamba

Aşağıdaki bulgular gecikmeksizin sistemik değerlendirme ve/veya endoskopi gerektirir.

● Kanlı/kronik ishal, gece semptomları, tenezm

● Büyüme duraklaması / kilo kaybı / gecikmiş puberte

● Perianal hastalık: fistül, apse, derin fissür, skin tag

● Piyoderma gangrenozum veya yaygın eritema nodozum

● Akut kırmızı göz / fotofobi / görme bulanıklığı (üveit)

● İnflamatuvar artrit / entezit / sakroiliit bulguları

● Genital ülser + rekürren oral aft (Behçet şüphesi)

● Majör/lineer oral ülser, dirençli aft, oral Crohn görünümü

● Anlamlı anemi, hipoalbüminemi, yüksek CRP/ESH veya kalprotektin

Üveit şüphesinde aynı gün oftalmolojik yarık lamba muayenesi kalıcı görme kaybını önler; tedavisiz üveit sineşi ve glokoma ilerleyebilir.

06 Tedavi (dozlu)

Basit RAS'ta topikal/semptomatik tedavi; altta yatan hastalık (IBD, çölyak, Behçet) doğrulandığında hastalığa özgü tedavi. Dozlar mg/kg ve maksimum ile verilmiştir.

Aftöz ülser ve ekstraintestinal bulgulara dozlu tedavi	
İLAÇ / BASAMAK	DOZ
Topikal kortikosteroid (triamsinolon orabaz / betametazon gargara)	Lezyona günde 2-3 kez ince t
Topikal anestezi / bariyer	%2 lidokain jel yemekten önce
Besinsel replasman — demir	Elementer demir 3-6 mg/kg/gü
Besinsel replasman — çinko	Çinko sülfat 1 mg/kg/gün elen
Kolşisin (dirençli RAS / Behçet mukokütanöz)	0,5-1,8 mg/gün toplam (yaklaş
Eksklüzif enteral nütrisyon (Crohn indüksiyon)	Hedef enerjinin %100'ü polime

İLAÇ / BASAMAK	DOZ
Kortikosteroid (IBD indüksiyon, EEN uygun değilse)	Prednizolon 1 mg/kg/gün (ma
5-ASA (mesalazin) — hafif-orta ÜK	Oral 60-80 mg/kg/gün (maks 4
Azatiyoprin (idame immünomodülatör)	2-2,5 mg/kg/gün (TPMT'ye gö
İnfliksimab (anti-TNF)	5 mg/kg IV; 0-2-6. hafta indüks
Adalimumab (anti-TNF, subkutan)	Yükleme ağırlığa göre (ör. ≥40
Glutensiz diyet (çölyak)	Ömür boyu tam glutensiz diyet

Ekstraintestinal bulgular (artrit, eritema nodozum, üveit, piyoderma) çoğunlukla altta yatan IBD/Behçet aktivitesiyle paralel seyreder; barsak/sistemik hastalığın kontrolü bu bulguları da geriletir. Piyoderma gangrenozum ve refrakter üveitte anti-TNF erken düşünülmelidir.

Tanı sonrası izlem, altta yatan hastalığa ve tedaviye göre yapılandırılır.

İzlem parametreleri

- Büyüme (boy/kilo/persantil) ve puberte her vizitte
- Klinik aktivite indeksleri (Crohn'da wPCDAI, ÜK'te PUCAI)
- Fekal kalprotektin ile mukozal iyileşme takibi (hedefe yönelik tedavi)
- TKS, CRP/ESH, albümin, ferritin; tiyopurin/anti-TNF alanda ilaç düzeyi ve immünojenisite
- Anti-TNF öncesi ve izlemde tüberküloz/hepatit taraması; aşı durumu
- Çölyakta anti-tTG ile diyet uyumu ve mukozal düzelme takibi

Multidisipliner ve destek

- Üveit varlığında düzenli oftalmoloji izlemi (sineşi/glokom önlenmesi)
- Artrit/entezit için romatoloji ile ortak yönetim
- Piyoderma/eritema nodozum için dermatoloji ile koordinasyon
- Beslenme desteği ve mikronütrient replasmanının sürdürülmesi
- Kemik sağlığı: uzamış steroidde D vitamini/kalsiyum, gerekirse densitometri
- Psikososyal destek ve tedavi uyumunun değerlendirilmesi

Hedef: klinik remisyon + biyokimyasal (CRP/kalprotektin normalizasyonu) ve mümkünse mukozal iyileşme. Ekstraintestinal bulgular yeniden alevlenirse barsak hastalığı aktivitesi yeniden değerlendirilmelidir.

Kaynaklar

1. van Rheenen PF, Aloï M, Assa A, et al. The Medical Management of Paediatric Crohn's Disease: an ECCO-ESPGHAN Guideline Update. J Crohns Colitis. 2021.
2. Turner D, Ruemmele FM, Orlanski-Meyer E, et al. Management of Paediatric Ulcerative Colitis: Joint ECCO and ESPGHAN Evidence-based Consensus Guidelines. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018.
3. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó I, et al. ESPGHAN Guidelines for Diagnosis of Coeliac Disease 2020. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020.
4. Levine A, Koletzko S, Turner D, et al. ESPGHAN Revised Porto Criteria for the Diagnosis of Inflammatory Bowel Disease in Children and Adolescents. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014.

Uyarı: Bu belge pediyatrik gastroenteroloji uzmanları için hazırlanmış bir klinik karar destek aracıdır; bireysel hastada klinik yargının, güncel kılavuzların ve ilaç prospektüs bilgisinin yerine geçmez. Dozlar uygulama öncesi doğrulanmalı ve hastaya göre uyarlanmalıdır.